

Información Paciente

Nombre : Yolanda De Las Margaritas Arias Sepulv **Rut** : 8.449.611-1 **N° Archivo** : A158102
Edad : 67a 3m 23d **Fecha Nacto**: 01/10/1955 **Sexo** : Femenino
Dirección : Cordillera De La Costa 2901 **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 975958690

N° Epicrisis
338259

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater) **Fecha Ingreso** : 29/11/2022 07:55 **Días Estadía**: 56
Unidad de Egreso : Utim (5to Piso Mater) **Fecha Egreso** : 24/01/2023 10:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Ingreso electivo para neurocirugía

Comorbilidades

Artritis Reumatoidea; Insuficiencia Cardíaca Congestiva; Crítica Crónica; Desnutrición;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

MÓRBIDOS: ICC FEp (EcoTT mayo 2022 con FEVI 62%, IAO leve), ERC Crea basal 1.3 (etapa IIIA), AR secuelada, hipoacusia, disfunción patelo femoral, Sd. Sjögren, subluxación anterior de C1-C2 y radiculopatía cervical C3-C4 y C8-T1 operada

QUIRÚRGICOS: Tenorrafia mano izq, cirugía descompresiva 14/03 + reducción completa y fijación cervical C1-C6 15/03. Aseos quirúrgicos 12/04 y 29/04.

FÁRMACOS: pregabalina 75 mg cada 12 hrs, baclofeno 10 mg cada 12 hrs, celecoxib 200 mg al día. Ácido fólico 5 mg día, Prednisona 7.5 mg día, Omeprazol 20 mg día, leflunomida 20 mg día, metotrexato 10 mg los jueves, Clonazepam 1 mg VO SOS, tramadol/paracetamol 1 comp cada 8 h.

ALERGIAS: Penicilina.

HÁBITOS: TBQ (+ 03/2022), OH (-), Drogas (-)

HOSPITALIZACIONES RECIENTES: marzo a julio 2022 por neurocirugía electiva complicada con infección de herida operatoria por C albicans y S haemolyticus MR con múltiples aseos quirúrgicos. De alta con disfagia y miopatía del paciente crítico en rehabilitación. Destacan intercurrentes resueltas: traqueobronquitis e ITU por PSAE MR, portación E. faecium van B, ITS CVC PSAE MDR, Bezoar esofágico extraído vía EDA, TQ T prolongada decanulada 10/07, AKI por colistin y vancomicina.

SOCIAL: Deambula en casa con andador, resto en silla de ruedas.

HISTORIA CLÍNICA

Paciente con antecedentes descritos, en seguimiento por UHD y múltiples especialidades en ambulatorio. Evoluciona con parestesias y dolor tenebrante que inicia en el hombro derecho, que luego se desplazó al hombro izquierdo y dermatomas de C6 y C7 del brazo, antebrazo y mano izquierda.

TAC: tornillo distal en posición de articulación facetaria, desplazamiento del segmento C1 a C6, con anterolistesis respecto de C7, sin compromiso del canal medular, estenosis foraminales progresivas en C6 y C7 a izquierda.

Se hospitaliza de forma electiva para resolución quirúrgica. 29/11 se realiza laminectomía descompresiva y fijación de columna segmento C6-C7, destacando colección en el sitio operatorio con contenido purulento. Queda con Drenaje al lecho, salida por contrabertura. Neuromonitoreo sin incidentes.

Se trasladó a UTIM, donde evoluciona:

HEMODINAMIA: estable durante toda su hospitalización. Ha recibido corticoides en dosis de estrés en relación a cirugías e intercurrentes infecciosas. Presentó bradicardia en contexto de laringoespasma, resuelve tras control de vía aérea.

Fecha Epicrisis : 24/01/2023 21:38

Página 1 de 4

VENTILATORIO: Sin conflicto inicial. El 14/12 no se logra IOT para pabellón, presentando laringoespasma y bradicardia, por lo que se realizó TQT de urgencia. Requirió VMI hasta el 15/12, consolidando weaning con bajos req. O2 por filtro. En contexto de nueva intercorriencia infecciosa requiere conexión a VMI del 31/12 al 02/01 por deterioro de mecánica respiratoria. 09/01 se realiza cambio de TQT por disfunción (7.5). En última semana tolerando ventanas a Válvula de fonación a tolerancia, sin embargo, por compromiso de conciencia progresivo, actualmente TQT con filtro. Se planifica en conjunto con familiares manejo en domicilio, educándose sobre su manejo.

INFECCIOSO: colección del sitio quirúrgico con cultivo positivo para 2 PSAE (ambas con sensibilidad a Tazonam, una intermedia) y ERV, cubriéndose con Tazonam y Linezolid. Aseo quirúrgico del 14/12 con cultivo (+) PSAE (S) Tazonam y Colistin, se indicó Tazonam, colistin (por sospecha de resistencia intratratamiento y se mantuvo Linezolid para cobertura de ERV. El 20/12 se rota Linezolid a tigeciclina por sospecha de pancitopenia. Dado deterioro y alza de PPII con UC y punta CVC (+) para C. albicans (con HCs periféricos (-)), se agregó anidulafungina, que luego se cambió por fluconazol por quiebre de stock. Estudio de diseminación: EcoTT 03/01, sin vegetaciones. FO sin alteraciones. TC cuello + TAP (23/12) informó colección de 5x3 cm en el sitio operatorio, RM de columna cervical de control (29/12) con colección de similar tamaño (3 cm x 6 cm), por lo que se ha mantenido cobertura de PSAE con distintos esquema s.

30/12 nuevamente febril, CAET (+) PSAE MR (S) Amikacina y Colistin. Evaluada con infecto, se decide suspender fluconazol y cubrir PSAE con Cefta/Avi + Aztreonam. 12/01 TAC de torax sin foco de condensación por lo que se completa tratamiento a los 7 días.

Se mantuvo febril desde el 14/01 y con PPII al alza, se pancultiva y se rescata BD glucano positivo 500. Evaluado por Infecto, se decide reiniciar fluconazol por sospecha de candidemia persistente + cefazolina para cobertura de PSAE presente en últimos cultivos de colección cervical. Evoluciona con compromiso de conciencia progresivo, clínicamente con LPP occipital y dehiscencia de herida operatoria con exposición ósea y de material quirúrgico. Dado evolución tórpida, fragilidad y alto riesgo operatorio, se define no realizar nuevas intervenciones quirúrgicas. Dado quiebre clínico en últimas 48 horas se decide dar por completado tratamiento antimicrobiano y privilegiar medidas de confort y acompañamiento familiar en domicilio.

NEUROCIRUGÍA: Se realiza laminectomía descompresiva y fijación cervical por aflojamiento de tornillos y mielopatía compresiva, destacando hallazgo de colección intraoperatoria. El 14/12 por evolución tórpida (subfebril, alza de PI, con perfil de resistencia intermedia a Tazonam en 1 cepa de PSAE) se drena colección + toma de cultivos. En seguimiento por neurocirugía, TAC control con estabilidad de colecciones, indican mantener collar cervical rígido solo en caso de movilización, autorizan movilización asistida (sentar borde cama). Drenaje Jackson Pratt retirado 21/12. Paciente evoluciona de forma desfavorable, con alto riesgo quirúrgico, por lo que se desestiman nuevas intervenciones quirúrgicas y en relación a esto se decide no controlar nueva imagen. Destaca como complicación, dehiscencia de herida operatoria cervical en curaciones con enfermería.

HEMATOLÓGICO: Pancitopenia con requerimientos intermitentes de Tx de GR y plaquetas por múltiples hematomas, además neutropenia 2rio a sepsis y uso de Linezolid (este último ya suspendido), ya recuperada. Mantiene anemia multifactorial.

MEDIO INTERNO: AKI (VEC bajo vs tubulopatía por colistin, ya suspendido), resuelta. Ha cursado con hipoK, Mg y P, en manejo con cargas parenterales. Se rescata Clearance crea en 46 ml/min/1.73m², se ajustan medicamentos por función renal.

REUMATOLÓGICO: AR secuelada, usuaria de corticoides, MTX y leflunomida. Recibió corticoides en dosis de estrés en relación a intervenciones quirúrgicas e intercorriencias infecciosas. DMARDs suspendidos en contexto infeccioso actual.

DERMATOLÓGICO: dermatitis erosiva del pañal. Se toma cultivo de lesiones y PCR HSV (-). Evaluada por Dermatología, deja pasta lassar abundante en mudas y Crema Nutraisdin ZN40 aplicar cada 12 horas.

REHABILITACIÓN:

- UPP: a nivel occipital UPP GII de 4-5 cm; a nivel sacro UPP GI-II en curaciones avanzadas por Enfermería, y con movilización. Se gestiona colchón antiescara con Fisiatría (GES ayudas técnicas).
- Tolera VF peri 6 hrs y paso a sillón.
- Nutricional: queda con SNG al alta dado escaso potencial de rehabilitación y pronóstico ominoso a corto plazo. Ingres a Ley Ricarte Soto para recibir alimentación enteral en domicilio, sin embargo, cursa con eventos de aspiración a pesar de alimentación enteral, por lo que, en relación a empeoramiento de condición clínica en últimas 48 horas, suspender alimentación enteral y mantener aporte de glucosa vía subcutánea.

ANALGESIA: en ajuste por CCPP, se rotó a metadona dado que con administración de morfina presentó sopor profundo que

requirió naloxona.

CCPP: en relación a deterioro desde última hospitalización, fragilidad, desnutrición marcada, múltiples intercurrentias infecciosas y proceso infeccioso que no será subsidiario a resolución quirúrgica, se solicita evaluación por CCPP. Evaluada por especialidad, se determina pronóstico ominoso a corto - mediano plazo. 11/01 realiza reunión con Jefatura y familia de paciente, en virtud de pronóstico determinado por equipo de CCPP. Se acuerda manejo conservador, privilegiar manejo en domicilio por lo que familia se educa en manejo de dispositivos invasivos. Sin embargo, en últimas 48 horas presenta mayor deterioro, por lo que se decide alta con UHD para cuidados de manejo fin de vida.

Diagnósticos

1. Obs Candidemia
2. Insuficiencia respiratoria aguda global
3. Laringoespasma con TQT de urgencia 14/12/22
4. Mielopatía compresiva de columna cervical
 - 4.1. Laminectomía y fijación 29/11
 - 4.2. Colección del sitio operatorio por PSAE y ERV
5. Dehiscencia de herida operatoria purulenta con exposición ósea y de material de osteosíntesis
6. UPP occipital
7. Miopatía del paciente crítico + Delirium
8. Dermatitis erosiva del pañal
9. Déficit de vitamina D
10. Resueltos:
 - 10.1. Traqueobronquitis por PSAE R Carba, S colistin
 - 10.2. Insuficiencia renal aguda
 - 10.2.1. Prerenal y tubulopatía por Colistín
 - 10.3. Pancitopenia multifactorial en resolución
 - 10.3.1. Linezolid + Sepsis + Consumo por hematoma de ESD°
11. Antecedentes: ICC FEVI 62%, ERC Crea 1.3, Artritis reumatoide, hipoacusia, Sd. Sjögren, radiculopatía cervical. Alergia a Penicilina. Vía aérea difícil

Diagnóstico de Egreso

Obs Candidemia 2. Insuficiencia respiratoria aguda global 3. Laringoespasma con TQT de urgencia -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente fragil, en cuidados fin de vida, traqueostomizada, usuaria sonda foley

Plan Post Alta

INDICACIONES:

Reposo relativo, cambio frecuente de posición
Cuidados por unidad de hospitalización domiciliaria
- O2 por traqueostomía
- Curación de LPP occipital y herida operatoria cervical
- Facilitar bomba de aspiración
- Cuidados sonda foley
Solución glucosalina a 20 cc/hora por vía subcutánea pectoral
Metadona 1 mg cada 12 horas vía subcutánea
Metadona 2 mg vía subcutánea en caso de necesidad
Aplicar pasta lassar en área del pañal en cada muda.
Nutraisdin ZN 40 crema, aplicar 2 veces al día en zonas erosivas.
Seguimiento por unidad de cuidados paliativos.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Semisentado 45°

Régimen Alimentario : Régimen Cero

Fecha Epicrisis : 24/01/2023 21:38

Página 3 de 4



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 24-01-2023 21:38:27

Página 4 de 4

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Ada Cascone Scarpatti

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 24/01/2023 21:38

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:51

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar